



Nomor : 2186/VII-05/0724
Lampiran : Dua berkas
Hal : Umpan Balik Utilisasi Kontrol Ulang RJTL dan Iterasi Obat

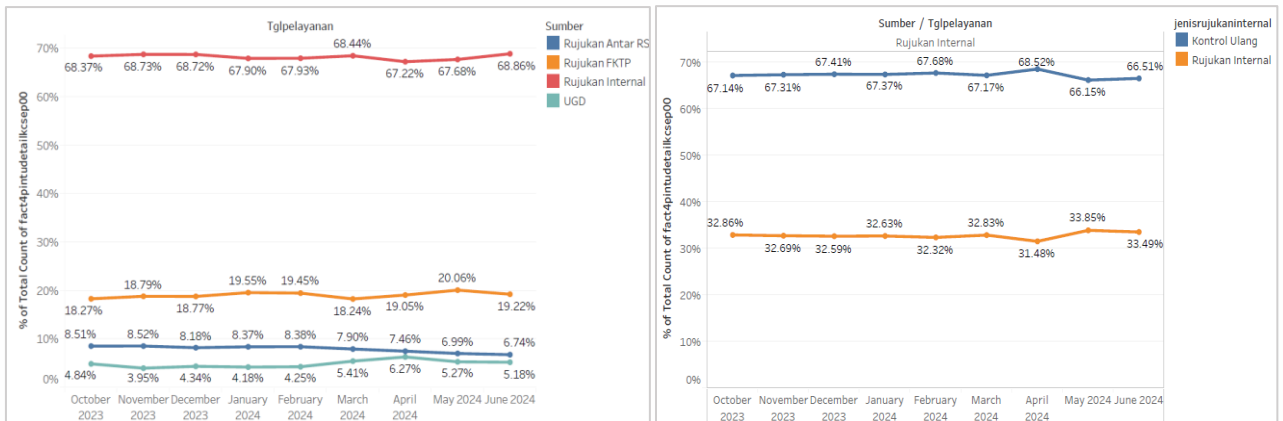
Malang, 2 Juli 2024

Yth. Direktur/Kepala FKRTL Mitra Kerjasama se-Malang Raya
di
Tempat

Pertama-tama kami manajemen BPJS Kesehatan Cabang Malang menyampaikan terimakasih atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menindaklanjuti tren kunjungan berulang di Rawat Jalan, berikut kami sampaikan umpan balik utilisasi kunjungan berulang di Rawat Jalan dan capaian iterasi obat kronis sebagai berikut :

1. Gambaran utilisasi kasus/kunjungan di Rawat Jalan



Asal kunjungan di tingkat Rawat Jalan tertinggi berasal dari Rujukan Internal/Kunjungan Kontrol yaitu sebesar 68% dengan proporsi terbesar berasal dari pemberian Surat Kontrol yaitu pada kunjungan poli yang sama dengan asal poli rujukan awal.

Kunjungan rawat jalan dengan frekuensi berulang tertinggi ada pada CBG's Q-5-44-0 Penyakit kronis kecil lain-lain yaitu pasien yang ruting berkunjung dengan diagnosa penyakit kronis.

Frekuensi Kunjungan Berulang Per Bulan (Q-5-44-0) All (RJTL)														
Month, Year of Bulan Pelayanan	1	2	3	4	Frekuensi Kunjungan Berulang									
2023 M11	75,284	37,766	14,595	5,556	1,745	546	189	64	27				11	
2023 M12	74,516	36,302	13,179	4,448	1,265	414	98	24	18	30				
2024 M01	80,214	40,076	15,963	5,796	2,015	516	196	56	27					15
2024 M02	77,240	35,504	11,814	4,080	1,100	306	63	16	9				13	
2024 M03	75,120	34,912	12,624	4,144	1,160	282	98	32	9					
2024 M04	72,535	30,738	10,011	2,916	730	156	35	16						

TOP 10 Diagnosa Q-5-44-0-PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

CBG	Diagnosa	Kasus
Q-5-44-0-PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	I119 - Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	13.847
	I251 - Atherosclerotic heart disease	13.772
	E119 - Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	11.166
	J449 - Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	8.425
	E118 - Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications	7.596
	I639 - Cerebral infarction, unspecified	5.915
	G409 - Epilepsy, unspecified	5.541
	I509 - Heart failure, unspecified	4.756
	J459 - Asthma, unspecified	4.735
	I10 - Essential (primary) hypertension	3.954

Berdasarkan data Top 10 diagnosa kunjungan RJTL-CBG Q-5-44-0 bulan Januari sd April 2024 terdapat **diagnosa PRB** yang berpotensi untuk dilakukan rujuk balik jika kondisinya terpenuhi validasi PRB (benar diagnosa, benar obat dan benar stabil) dan **diagnosa penyakit kronis lain** yang dapat dilakukan peresepan **iterasi**. Agar masing-masing FKRTL dapat melakukan evaluasi kembali terhadap potensi kasus PRB dan mengoptimalkan pelayanan obat iterasi pada kasus penyakit kronis non kasus PRB.

2. Capaian Iterasi Peresepan Obat

Berikut adalah capaian iterasi peresepan obat di FKRTL Tahun 2024 (berdasarkan No SEP yang diiter)

No	Nama FKRTL	Capaian Iterasi				
		January 2024	February 2024	March 2024	April 2024	Total
1	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	703				703
2	RS WAVA HUSADA	96	186	188		470
3	RSK Bedah Hasta Husada	69	73	83	14	239
4	RS PINDAD	38	21	50	18	127
5	RS MARSUDI WALUYO	25	29	-	-	54
6	KLINIK JANTUNG HASNA MEDIKA	-	-	69	-	69
7	RS PRIMA HUSADA	24	8	-	-	32
8	RS PERMATA BUNDA	4	5	2	-	11
9	KLINIK SAFIRA MED. CENTRE	4	3	-	-	7
10	RS BEN MARI	14	2	-	-	16
11	RS LAVALETTE	16	-	-	-	16
12	RS UNIV. MUHAMMADIYAH	1	-	6	-	7
13	RS PURI BUNDA	3	2	1	3	9
14	RS ISLAM UNISMA	7	-	-	-	7
15	RS BALA KES. BOKOR	1	1	2	-	4
16	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	3	-	-	-	3
17	RSI AISIYIAH MALANG	3	-	-	-	3
18	RS SUMBER SENTOSA	2	-	2	-	4
19	RS DR. ETTY ASHARTO	-	-	-	2	2
20	RSUD Kanjuruhan	2	-	-	-	2
21	RS ISLAM MADINAH	-	-	1	-	1
22	RS WAJAK HUSADA	-	1	-	-	1
23	RS Universitas Brawijaya	2	-	-	-	2
24	RS. JIWA LAWANG	-	-	-	-	-
25	RSU KARSA HUSADA BATU	-	-	-	-	-
26	RSU dr Saiful Anwar	-	-	-	-	-
27	RS PUNTEN	-	-	-	-	-
28	RS Brimedika	-	-	-	-	-

No	Nama FKRTL	Capaian Iterasi				
		January 2024	February 2024	March 2024	April 2024	Total
29	RSIA PURI	-	-	-	-	-
30	RSIA MUTIARA BUNDA	-	-	-	-	-
31	KLINIK UTAMA BUNGA MELATI	-	-	-	-	-
32	RS PERSADA HOSPITAL	-	-	-	-	-
33	RSIA GALERI CANDRA	-	-	-	-	-
34	RS MELATI HUSADA	-	-	-	-	-
35	RS KLINIK PACCE	-	-	-	-	-
36	RS SITI MIRIAM	-	-	-	-	-
37	RS AU DR.M.MUNIR ABD. SALEH	-	-	-	-	-
38	RS ISLAM GONDANGLEGI	-	-	-	-	-
39	RS PRASETYA HUSADA	-	-	-	-	-
40	RS LAWANG MEDIKA	-	-	-	-	-
41	RS RUMKITBAN LAWANG	-	-	-	-	-
42	RSUD LAWANG	-	-	-	-	-
43	RS PANTI NIRMALA	-	-	-	-	-
44	RS MITRA DELIMA	-	-	-	-	-
45	RS PANTI WALUYA	-	-	-	-	-
46	RS BHIRAWA BHAKTI	-	-	-	-	-
47	RS BAPTIS	-	-	-	-	-
48	KLINIK MUSLIMAT SINGOSARI	-	-	-	-	-
49	RS DR. SOEPRAOEN	-	-	-	-	-
50	RS Umum Daerah Kota Malang	-	-	-	-	-
51	Klinik Teja Husada	-	-	-	-	-
52	Klinik Malang Eye Center	-	-	-	-	-
53	Klinik Kepanjen Eye Center	-	-	-	-	-
54	Klinik SMEC Malang	-	-	-	-	-
55	RSIA MARDI WALOEJA KAUMAN	-	-	-	-	-
56	RSIA MUHAMMADIYAH MALANG	-	-	-	-	-
TOTAL		1.017	331	404	37	

Berdasarkan data di atas, belum seluruh FKRTL mengimplementasikan dan mengoptimalkan kebijakan iterasi persepsan obat kronis. Kebijakan iterasi obat mengikuti surat nomor 1439/VII-05/0721 perihal Teknis Kebijakan Penjaminan Pelayanan Obat Penyakit Kronis dan Obat Kemoterapi Oral di FKRTL Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Untuk meningkatkan pemanfaatan iterasi, berikut kami sampaikan **data potensi PRB dan iterasi** berdasarkan diagnosa dan pemberian obat rutin setiap bulan (obat kronis dan kemoterapi oral) sehingga diharapkan dapat mencapai target iterasi sebagaimana terlampir.

a. Potensi data PRB dan Iterasi berdasarkan Noka Peserta (rincian data terlampir)

No	Nama FKRTL	Potensi Iterasi	No	Nama FKRTL	Potensi Iterasi
1	RSI AISIYAH MALANG	5.702	26	RSU KARSA HUSADA BATU	795
2	RSUD DR. SAIFUL ANWAR	4.249	27	RS DR. ETTY ASHARTO	724
3	RS WAWA HUSADA	2.929	28	RSU WAJAK HUSADA	703
4	RSU. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	2.850	29	RS PRASETYA HUSADA	690
5	RUMAH SAKIT LAVALETTE	2.762	30	RS PANTI WALUYA	682
6	RS PRIMA HUSADA	2.549	31	Klinik Utama Bunga Melati	454
7	RSU PINDAD	2.170	32	RSUD Kota Malang	379
8	RS SOEPRAOEN	1.930	33	RS AU DR.M. munir	303
9	RSJ DR RADJIMAN WEDIODININGRAT	1.838	34	RS LAWANG MEDIKA	302
10	RSU HERMINA TANGKUBANPRAHU	1.560	35	KLINIK SAFIRA MEDICAL CENTRE	295
11	RS Mitra Delima	1.479	36	RS BEN MARI	273
12	RS PERSADA HOSPITAL	1.475	37	RS BHIRAWA BHAKTI	252
13	RS MARSUDI WALUYO	1.470	38	RS SUMBER SENTOSA	177
14	RS ISLAM MALANG UNISMA	1.411	39	RS PUNTEN	169
15	RS. BAPTIS BATU	1.386	40	KLINIK PACCE	142
16	RS PANTI NIRMALA	1.334	41	RSU PERMATA BUNDA	129
17	RS Universitas Brawijaya	1.256	42	KLINIK RI MUSLIMAT SINGOSARI	120
18	RSUD Kanjuruhan	1.211	43	RUMKITBAN 05.08.04 LAWANG	110
19	KLINIK JANTUNG HASNA MEDIKA	1.094	44	RSIA GALERI CANDRA	71
20	RS K Bedah Hasta Husada	1.002	45	RS MELATI HUSADA	51
21	RSI GONDANGLEGI	991	46	RS SITI MIRIAM	46
22	RSUD LAWANG	984	47	RSIA PURI BUNDA	18
23	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	934	48	RSIA MUHAMMADIYAH MALANG	12
24	RS Bala Keselamatan Bokor	904	49	RSIA PURI	13
25	RSUI MADINAH KASEMBON	820	50	RSU BRIMEDIKA	10
			51	RSIA MUTIARA BUNDA	7

b. Target Iterasi

No	Nama FKRTL	Target Iterasi	No	Nama FKRTL	Target Iterasi
1	RSI AISYIYAH MALANG	4.255	29	RS PRASETYA HUSADA	294
2	RSUD DR. SAIFUL ANWAR	350	30	RS PANTI WALUYA	291
3	RS WAVA HUSADA	4.150	31	Klinik Utama Bunga Melati	120
4	RSU. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	672	32	RSUD Kota Malang	124
5	RUMAH SAKIT LAVALETTE	947	33	RS AU DR.M. munir	149
6	RS PRIMA HUSADA	1.012	34	RS LAWANG MEDIKA	49
7	RSU PINDAD	921	35	KLINIK SAFIRA MEDICAL CENTRE	48
8	RS SOEPRAOEN	563	36	RS BEN MARI	185
9	RSJ DR RADJIMAN WEDIODININGRAT	119	37	RS BHIRAWA BHAKTI	98
10	RSU HERMINA TANGKUBANPRAHU	5.988	38	RS SUMBER SENTOSA	45
11	RS Mitra Delima	740	39	RS PUNTEN	42
12	RS PERSADA HOSPITAL	432	40	KLINIK PACCE	89
13	RS MARSUDI WALUYO	735	41	RSU PERMATA BUNDA	50
14	RS ISLAM MALANG UNISMA	563	42	KLINIK RI MUSLIMAT SINGOSARI	35
15	RS. BAPTIS BATU	347	43	RUMKITBAN 05.08.04 LAWANG	30
16	RS PANTI NIRMALA	332	44	RSIA GALERI CANDRA	25
17	RS Universitas Brawijaya	419	45	RS MELATI HUSADA	15
18	RSUD Kanjuruhan	606	46	RS SITI MIRIAM	25
19	KLINIK JANTUNG HASNA MEDIKA	417	47	RSIA PURI BUNDA	31
20	RS K Bedah Hasta Husada	466	48	RSIA MUHAMMADIYAH MALANG	4
21	RSI GONDANGLEGI	313	49	RSIA PURI	3
22	RSUD LAWANG	745	50	RSU BRIMEDIKA	15
23	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	444	51	RSIA MUTIARA BUNDA	2
24	RS Bala Keselamatan Bokor	452	52	Klinik Teja Husada	2
25	RSUI MADINAH KASEMBON	232	53	RSIA MARDI WALOEJA KAUMAN	-
26	RSU KARSA HUSADA BATU	370	54	Klinik Malang Eye Center	-
27	RS DR. ETTY ASHARTO	254	55	Klinik Kepanjen Eye Center	-
28	RSU WAJAK HUSADA	328	56	Klinik SMEC Malang	-

Mengingat Iterasi dihitung dari nomor SEP yang diiter resepnya, maka satu orang peserta dapat diiter sampai dengan 4 kali dalam satu tahun.

3. Optimalisasi capaian rekrutmen PRB

Dalam rangka meningkatkan capaian rekrutmen PRB, berikut disampaikan kembali kriteria stabil 9 (sembilan) diagnosa PRB berdasarkan Rekomendasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Pusat untuk dijadikan sebagai pedoman penetapan kriteria kondisi stabil 9 (sembilan) kasus PRB yang dapat dirujuk balik sehingga dapat mengoptimalkan capaian implementasi PRB (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala



Roni Kurnia Hadi Permana



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Rekomendasi Organisasi Profesi (IDI dan Perhimpunan Terkait) tentang Kriteria Stabil 9 Kasus Pasien Rujuk Balik (PRB)

A. Epilepsi

Rekomendasi	PERDOSSI
Klinis	1. Bebas serangan selama 6 bulan 2. Telah tercapai dosis rumatan obat anti epilepsi 3. Tidak ada efek samping obat 4. Tidak ada komorbid
Catatan	1. Jenis OAE yang tersebut dalam resep pasien harus tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 2. Obat yang diberikan untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari setiap kali peresepan dan harus sesuai dengan standar obat formularium nasional. 3. Perubahan / penggantian obat hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis / sub spesialis yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 4. Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan
Daftar Pustaka	Permenkes Nomor 5 tahun 2014, Panduan praktik klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

B. Stroke

Rekomendasi	PERDOSSI
Klinis	1. Kondisi pasien stabil walaupun masih didapatkan sekuele stroke infark atau hemoragik 2. Eksplorasi faktor risiko stroke sudah selesai dilakukan (pengukuran tekanan darah, perekaman EKG dan pemeriksaan laboratorium darah berupa profil lipid, gula darah, kadar asam urat) 3. Faktor risiko yang ada pada pasien terkendali: a. Tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg (bagi yang memiliki riwayat diabetes melitus), dan kurang dari 140/90mmHg (bagi yang tidak memiliki diabetes melitus). b. Gula darah puasa antara 80 – 130 mg/dL c. Kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dL (bagi yang memiliki riwayat penyakit Jantung coroner, dan kurang dari 130 mg/dL (bagi yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung coroner). d. Kadar asam urat kurang dari 6 mg/dL (perempuan) dan



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

	kurang dari 7 mg/dL (laki-laki) 4. Tidak ada faktor risiko lain selain yang disebut di atas (misalnya kelainan sel darah, AVM, atrial fibrilasi, dll) 5. Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi.
Catatan	1. Obat yang diberikan untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari setiap kali peresepan dan harus sesuai dengan standar obat formularium nasional. 2. Perubahan / penggantian obat hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis / sub spesialis yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 3. Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan
Daftar Pustaka	PNPK Stroke, 2019. Perdossi Guideline stroke, 2011

C. Penyakit Jantung Hipertensi

Rekomendasi	PAPDI dan PERKI
Klinis	1. Tidak ada tanda gagal jantung (kongestif) berupa sesak napas atau nyeri dada dalam observasi selama 3 bulan 2. Tidak ada aritmia 3. Tekanan darah terkontrol baik pada waktu istirahat maupun aktivitas (TD < 140/90 mmHg) dalam waktu 3 bulan 4. Tidak terdapat keterbatasan aktivitas berupa sesak napas dan/atau nyeri dada selama observasi 3 bulan
Catatan	Penunjang Medis Echocardiografi 6 bulan sekali
Daftar Pustaka	PERKI. 2016. Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

D. Pasca Infark Miokardium (STEMI dan NSTEMI/UAP)

Rekomendasi	PERKI dan PAPDI
Klinis	1. Telah dilakukan revaskularisasi (PCI/CABG) sesuai indikasi 2. Klinis pasien stabil dengan gejala nyeri dada/angina maksimal CCS kelas 1 selama evaluasi 3 bulan. 3. Kapasitas fungsional sesuai dengan NYHA I-II 4. Sudah mendapatkan terapi dual antiplatelet (aspirin dan clopidogrel) 5. Sudah mendapatkan beta blocker dengan dosis optimal dengan target nadi istirahat < 70 kali permenit 6. Telah mendapatkan obat golongan statin intensitas tinggi yang akan dilanjutkan di FKTP 7. Telah mendapatkan obat golongan ACE-Inhibitor atau ARB jika kontraktilitas ventrikel kiri menurun (EF < 40 %) atau hipertensi 8. Tekanan Darah Terkontrol TD < 140/90 mmHg
Catatan	Pasien tidak dirujuk balik jika pasien masih memerlukan ticagrelor (brilinta) paska PCI. Pasien segera dirujuk ulang ke FKTL jika ada perburukan nyeri dada dan obat-obatan tidak bisa disediakan di FKTP secara lengkap.
Daftar Pustaka	PERKI. 2016. Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

E. Angina Pektoris Stabil

Rekomendasi	PERKI dan PAPDI
Klinis	1. Telah dilakukan revaskularisasi (PCI/CABG) sesuai indikasi 2. Tidak ada sesak nafas atau keluhan nyeri dada saat beraktifitas. 3. Sudah mendapat antiplatelet (single antiplatelet atau dual antiplatelet pada pasien paska PCI), beta bloker dosis optimal dan obat golongan statin intensitas tinggi
Catatan	-
Daftar Pustaka	PERKI. 2016. Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

F. Gagal Jantung Kronik

Rekomendasi	PERKI dan PAPDI
Klinis	1. Pasien bebas keluhan sesak nafas (NYHA Fc I-II) selama observasi 3 bulan 2. Volume cairan tubuh tidak bertambah selama 3 bulan berturut-turut 3. Secara hemodinamik stabil dengan kriteria : tekanan darah > 90/60 mmHg dengan produksi urin tercapai sesuai klinis. 4. Penyebab gagal jantung akut sudah teridentifikasi dan teratasi 5. Telah mendapatkan terapi gagal jantung sesuai dengan pedoman tatalaksana gagal jantung dan memantau klinis pasien agar tetap dalam keadaan euvolemik
Catatan	Bila terdapat kriteria tidak stabil berikut , maka harus dirujuk kembali ke FKTL : 1. Ada perburukan sesak nafas yang progressif 2. Terlihat tanda penumpukan cairan tubuh (JVP) meningkat, terdapat ronki basah di paru, asites bertambah, edema kaki) yang tidak membaik dengan furosemid oral atau restriksi cairan. Pasien tidak dirujuk balik apabila : 1. Menonsumsi warfarin yang membutuhkan pemeriksaan darah INR (International Normalized Ratio), misalnya pasien dengan komorbid atrial fibrilasi atau pasca operasi katup jantung 2. Pasien yang memerlukan obat-obatan lain yang tidak termasuk dalam Fornas PRB (misalnya ivabradin, sildenafil dan beraprost/dorner) karena hanya tersedia di FKRTL 3. Pasien gagal jantung tidak dirujuk balik jika terpasang device ICD, CRT, CRTD, LVAD atau alat pendukung sirkulasi mekanik lain Semua kasus rujuk balik penyakit jantung diatas, setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi.
Daftar Pustaka	-



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

G. Diabetes Mellitus

Rekomendasi	PAPDI dan PERKENI
Klinis	1. GDP 80-130 mg/dl 2. GD 2PP < 180 mg/dl 3. HbA1c < 7% (waktu pemeriksaan tiap 6 bulan sekali) 4. Tekanan darah sistolik < 140 mmHg 5. Tekanan darah diastolik < 90 mmHg 6. Kolesterol LDL < 100 (<70 bila risiko KV sangat tinggi) 7. Kolesterol HDL : Laki-laki > 40, Perempuan > 50 8. Tidak ada komplikasi akut dan/atau kronik (makrovaskular dan mikrovaskular) yang masih membutuhkan diagnosis dan tatalaksana lebih lanjut di FKTL. 9. Pada Diabetes Mellitus yang terkontrol dengan insulin, dipastikan tersedia insulin dengan jenis dan cara kerjanya yang sesuai di FKTP. 10. Bukan Diabetes Gestasional dan/atau Diabetes Tipe Lain
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan.
Daftar Pustaka	Permenkes Nomor 5 Tahun 2014, Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer PB PERKENI. 2015. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Type 2 di Indonesia 2015 ADA. 2018. Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Vol.41, Supplement 1.

H. Hipertensi

Rekomendasi	PAPDI, PERHI, dan PERNEFRI
Klinis	1. Tekanan darah < 140/90 mmHg, dalam waktu 3 bulan 2. Tidak ada penyakit penyerta lain 3. Tidak terdapat <i>Hypertension Mediated Organ Damaged</i> (HMOD), yaitu Payah Jantung, Penyakit Ginjal Kronik stadium III-V (eGFR < 60 ml/min), Penyakit Jantung Koroner, Stroke, Penyakit Vaskular Perifer, aritmia dan/atau Atrial Fibrilasi. 4. Bukan Hipertensi Sekunder, Hipertensi Pulmonal, dan/atau Hipertensi pada kehamilan 5. Dianjurkan untuk mengukur TD sendiri di rumah (PTDR) atau di fasilitas kesehatan terdekat 6. Disarankan bahwa Penatalaksanaan Hipertensi di FKTP adalah Hipertensi derajat 1 (TD 140 -150/90-99 mmHg dengan Tahap 1 (tidak berkomplikasi dengan 1-2 faktor risiko)
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

	dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan kemungkinan perubahan jenis dan dosis bila diperlukan.
Daftar Pustaka	Permenkes Nomor 5 Tahun 2014, Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Primer. Whelton et al. 2017. Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults. AHA. 2017. DOI: 10.1161/HYP.0000000000000065

I. Asma

Rekomendasi	PAPDI dan PDPI
Klinis	- Asma stabil dan terkontrol menurut <i>Asthma Control Test</i> ≥ 20 atau secara klinis apabila pasien dalam 4 minggu memenuhi seluruh parameter gejala dalam '<i>Asthma Symptoms Control</i>' sebagai berikut: - Tidak ada gejala harian asma lebih dari 2x seminggu - Tidak terbangun pada malam hari akibat sesaknya - Tidak memerlukan obat pelega lebih dari 2x seminggu - Tidak ada keterbatasan aktivitas fisik karena asmanya - Asma ringan dan sedang yang stabil, yaitu tidak membutuhkan obat-obat berikut : - Kortikosteroid inhalasi dosis sedang hingga tinggi (untuk dewasa budesonide >400 mcg/hari, flutikason > 250 mcg/hari) - Kortikosteroid sistemik - Tidak memiliki penurunan fungsi paru berat ($FEV_1 \geq 60\%$ prediksi) - Tidak ada riwayat intubasi dan/atau perawatan ICU karena asma - Tidak ada eksaserbasi berat dalam 12 bulan terakhir - Tidak disertai komorbid yang termasuk ke PRB yang belum tertatalaksana dengan baik - Pasien tidak disertai komorbid yang tidak termasuk PRB
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi.
Daftar Pustaka	Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020. Tersedia dari www.ginasthma.org



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

J. PPOK

Rekomendasi	PAPDI dan PDPI
Klinis	1. Penilaian dilakukan secara klinis a. Pasien dengan skor mMRC (<i>Modified British Medical Research Council</i>) 0-1 atau skor CAT (<i>COPD Assessment Test</i>) kurang dari 10, DAN b. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak ada riwayat eksaserbasi 0 atau 1 kali (memerlukan rawat inap RS) atau > 1 kali tanpa perawatan RS 2. Pasien PPOK tidak disertai komorbid yang termasuk ke PRB yang belum tertatalaksana dengan baik 3. Pasien tersebut sudah di follow up dalam bulan dengan kondisi klinis baik tanpa komorbid, mengerti regimen pengobatan dan teknik inhaler yang digunakan dan mampu melakukan aktivitas fisik untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi
Daftar Pustaka	Global Initiative for Chronic Lung Disease (GOLD). Global Strategy for The Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2020

K. SLE

Rekomendasi PAPDI agar tidak dimasukkan ke dalam Program Rujuk Balik karena menurut SKDI : Kompetensi Dokter Umum untuk SLE adalah IIIA. Kasus SLE pada umumnya kompleks dan sulit diprediksi sehingga tidak dianjurkan untuk rujuk balik.

L. Skizofrenia

Rekomendasi	PDSKJI
Klinis	1. PANSS-remisi (P1,P2,P3,N1,N4,N6,G5,G9) semua skor komponen lebih kecil atau sama dengan 3; 2. Tercapai dosis fase rumatan antipsikotik; 3. Skizofrenia tanpa TACC (time= episode pertama, age= anak remaja dan usia lanjut, comorbidity= komorbiditas seperti ketergantungan zat, gangguan kepribadian, kondisi medis umum yang tidak terkendali, kasus forensik dll), complication = komplikasi seperti efek samping obat berat, deficit kognitif), 6 bulan tanpa kekambuhan;



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Catatan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali perlu dilakukan rujukan kembali kepada dokter spesialis / sub spesialis di fasilitas tingkat lanjutan dengan ada keluhan atau tidak ada keluhan dengan tujuan agar dapat dilakukan evaluasi
Daftar Pustaka	Surat Petunjuk Teknis Skizofrenia tentang Kriteria Rujuk dan Rujuk Balik dari PDSKJI ke Subdit Rujukan Bagian Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tanggal 22 Agustus 2019. Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 Tahun 2015 tentang PNPK Jiwa.